

+3.09%

30 年ぶりの大幅引き上げ

+1.70%

賃上げ

+0.76%

物価高騰

+0.09%

食費等

+0.44%

経営難

この改定で「あなたの給料」は上がるのか？ 「あなたの診療」はどう変わるのか？

今日の学習目標（15 分）

説明できる

改定の全体像と 4 つの柱

判断できる

自院の設定で何が変わるか

提案できる

BCP 策定・医療 DX 対応の具体的アクション

Quick Poll

☒ 前回（2024 年度）の改定内容を覚えている人？

☒ 「生活習慣病管理料」を算定したことがある人？

☐ BCP って何の略？

2024 年改定で DX 推進体制整備加算が新設。2026 年はその延長線上にありつつ大幅再編。

改定の 4 つの柱

1

賃上げ・物価対応

ベースアップ評価料を大幅拡充
全職員対象に

2

医療 DX 推進

既存加算を統合→1 本化
マイナ保険証利用率がカギ

3

かかりつけ医機能強化

地域包括診療加算の再編
BCP 策定が施設基準に

4

急性期再編と連携

入院料の細分化
救急外来の新評価

柱 1: あなたの給料

ベースアップ評価料

6 点

旧



17 点

新 (+11 点)

- 対象：医療従事者 → 事務職員含む全職員に拡大
- 物価対応料：初診 2 点・再診 2 点（新設、2027 年度に倍増予定）
- 再診料：75 点 → 76 点（微増だが全再診に波及）

既存 2 加算 → 1 つに統合

旧制度

医療 DX 推進体制整備加算

医療情報取得加算



新制度

電子的診療情報連携
体制整備加算

初診：最大 15 点（3 区分）

区分 1 15 点

マイナ利用率 30% 以上 + 電子処方箋実績

区分 2 9 点

電子処方箋体制あり

区分 3 4 点

マイナ保険証基本体制のみ

BCP 策定が義務化

対象となる施設基準

- 機能強化加算（80点）
- 在宅療養支援診療所（在支診）
- 在宅療養支援病院（在支病）

策定すべき内容

- 自然災害への対応計画
- サイバーセキュリティ対策

期限

2027 年 5 月末

（経過措置期限）

ケースディスカッション

あなたは地方の 200 床の病院で総合診療科の専攻医です。
院長から「今回の改定で当院がとるべきアクションをまとめてほしい」と言われました。

問い 1 外来：最優先で対応すべき改定項目は？

問い 2 入院：地域包括医療病棟のどの区分を目指す？

問い 3 全体：DX と BCP の優先順位は？

ペアワーク 3 分 → 2-3 ペアからシェア

持ち帰りの3アクション

今週

マイナ保険証利用率を確認する
→ 区分1（15点）に届くか？

来月

BCP策定の現状を上司に確認する
→ 未着手なら着手を提案

6月まで

自分の診療設定での算定変更を1つ把握する
→ チートシート（配布資料）を参照

詳細は配布チートシート（DOCX）を確認してください